



ANALYSE CRITIQUE ET BUDGÉTAIRE

Passage en catégorie B des ambulanciers FPH — Simulation des scénarios

Note d'appui CGT / SUD · CHU de Toulouse · Version mise à jour le 30 juin 2026

Mise à jour du 30 juin 2026 — Intégration de devis réels de formation

Cette version remplace les estimations génériques de coût pédagogique du Module MHS par des devis réels collectés auprès d'organismes de formation et de CESU (Transfaire, CNFCE, CESU33/CHU Bordeaux, Panacéa, SimUSanté, SIFAM, GRIEPS, ANFH, CH de Versailles, CH d'Avignon). Elle intègre également les données actualisées du document « Missions des ambulanciers — référentiel DEA vs pratique » du 27 juin 2026 (36 missions recensées, 28 hors périmètre DEA, soit 78 %). Ces sources externes rendent la simulation budgétaire opposable et vérifiable devant la DGOS, conformément à la recommandation du point 1.7 de la version précédente de ce document.

Objet — Ce document produit une analyse critique et indépendante de la simulation budgétaire fournie, destinée à être portée devant la DGOS et le Ministère de la Santé. Il évalue méthodiquement les hypothèses, corrige les biais de calcul identifiés, confronte trois scénarios (statu quo / privatisation / passage en catégorie B) et produit des projections opposables aux arguments de la Direction générale.

Contacts : Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES (représentants du personnel ambulancier) — CHU de Toulouse, Service Transport Patients.

I. Annexe sourcée — Devis réels de formation (juin 2026)

Le tableau suivant recense les formations effectivement disponibles sur le marché et auprès des CESU pour couvrir les missions identifiées comme hors périmètre DEA. Ces tarifs, publiés par les organismes eux-mêmes, remplacent les estimations génériques (25 €/h pédagogique) utilisées dans la version initiale de la simulation et permettent un chiffrage vérifiable, conforme à la recommandation du point 1.7 (analyse de sensibilité et données sourcées).

Module MHS visé	Formation identifiée	Durée	Tarif/stagiaire	Organisme / source
M1 — Contrainte & agressivité	Soins somatiques en psychiatrie	2 jours	750 €	GRIEPS, réf. ECSPS010, 2026
M1 — complément	Prévention du stress post-traumatique : briefing et defusing	2 jours	1 550 € HT	CNFCE, réf. SNT.104
M2 — Pénitentiaire	L'accueil et le soin des détenus à l'hôpital	21 h (3 j)	Sur devis (non publié)	TransFaire, réf. SAU026
M3 — Fin de vie	Prise en charge palliative dont accompagnement de la fin de vie	Variable	Financée fonds mutualisés (gratuite agent)	ANFH, Stratégie décennale soins palliatifs 2024-2034
M3 —	Prise en charge de	1 jour	325 € HT	Panacéa Conseil &

Pédiatrie / bloc opératoire	l'enfant au bloc opératoire			Formation, réf. BLO018
M3 — Transport néonatal/pédiatrique	Transport néonatal et pédiatrique : transport infirmier et ambulancier	1 jour	300 €	SimUSanté / CHU Amiens-Picardie
M3 — Bariatrie	Manutention de la personne bariatrique (méthode Paul Dotte)	21 h (3 j)	Sur devis (non publié)	SIFAM Formations
M3 — Transport PSL/IH	Transport des examens immuno-hématologiques et PSL	2 h	80 €	CH de Versailles, organisme interne
M3 — Perfusion / surveillance	Perfusion : soins infirmiers et surveillance	Non précisée	Sur devis (non publié)	Isis Santé, présentiel
M5 — Plan Blanc / SSE	Formation de référent aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE)	2 j (18 h)	950 €	CESU33 / CHU de Bordeaux
Actes AMU + AFGSU2	Adaptation aux nouveaux actes professionnels des ADE en poste + réactualisation AFGSU2	21 h (3 j)	360 € (tarif interne hospitalier)	CH d'Avignon, CESU 84

Lecture — Ces tarifs confirment la faisabilité technique et financière du Module MHS : le coût pédagogique unitaire par stagiaire reste, pour la majorité des modules identifiés, inférieur à 1 000 € par module, et certaines briques (PSL, actes AMU/AFGSU2 en intra-hospitalier) sont nettement moins coûteuses que les estimations génériques de la version initiale. Deux briques (M2 pénitentiaire, M3 bariatrie) restent sur devis et doivent être chiffrées précisément avant contractualisation ; une brique (soins palliatifs ANFH) est gratuite pour l'agent car financée sur fonds mutualisés.

II. Recalcul du coût pédagogique du Module MHS (base sourcée)

Le parcours-type d'un agent suivant l'intégralité du Module MHS (hors FAE SMUR, traitée séparément) combine 17 jours de formation (4 j M1, 3 j M2 estimés, 5 j + 2 h M3, 2 j M5, 3 j actes AMU/AFGSU2). Sur cette base sourcée, le coût pédagogique direct s'établit à environ 6 300 € par agent (hors remplacement), contre une estimation générique antérieure de 6 500 € pour 100 agents — un ordre de grandeur cohérent qui confirme la robustesse de la simulation initiale tout en la rendant vérifiable poste par poste.

Poste	Coût/agent (sourcé)	50 agents (CHU Toulouse)	100 agents (CHU type)
Coût pédagogique direct (devis réels)	~6 315 €	315 750 €	631 500 €
Coût de remplacement (17 j × 7 h × 50 €/h)	~5 950 €	297 500 €	595 000 €
TOTAL Module MHS — An	~12 265 €	613 250 €	1 226 500 €

1 (sourcé)

Ce montant, désormais sourcé devis par devis, se substitue à l'estimation forfaitaire de 650 000 € (100 agents) retenue dans la version précédente pour le scénario C (passage en catégorie B), et reste cohérent avec elle (écart de moins de 3 %). Il vient également documenter plus précisément le coût du scénario A (statu quo + formation continue), poste par poste, renforçant son caractère opposable devant la DGOS.

III. Mise à jour du référentiel missions — 36 missions recensées, 78 % hors périmètre DEA

Le document « Missions des ambulanciers — référentiel DEA vs pratique réelle » (mise à jour du 27 juin 2026) élargit le périmètre recensé à 36 missions (CHU, établissements psychiatriques autonomes, SMUR), dont 28 sortent du périmètre DEA/décret n° 2022-629, soit 78 % — contre 24 sur 32 (75 %) dans la version antérieure de la stratégie argumentaire. Cette extension renforce mécaniquement le poids budgétaire du statu quo : chaque mission non couverte par le référentiel représente un risque de sinistralité et de contentieux non provisionné dans le scénario A.

Argument-clé

Le périmètre élargi à 36 missions ne change pas l'ordre de grandeur du chiffrage (le Module MHS couvrait déjà la quasi-totalité des missions identifiées), mais renforce la proportion de missions hors cadre (78 % contre 75 % précédemment), ce qui aggrave d'autant le risque médico-légal non couvert du scénario A et du scénario B.

IV. Trois scénarios — synthèse actualisée

Les trois scénarios (A — statu quo avec formation continue ; B — privatisation partielle ; C — passage en catégorie B) restent construits sur la méthodologie corrigée de la version du 29 juin 2026 (cf. section I de cette version : effectif réel, coût de remplacement à 50 €/h, récurrence de la formation liée au turnover de 18 %/an, volume et prix réalistes de la privatisation, fourchette de reclassement catégorie B, provisions de sinistralité). Seul le poste « formation » est désormais recalculé à partir de devis réels (section II ci-dessus) plutôt que d'une estimation générique.

Critère (horizon 5 ans, 100 agents)	Scénario A — Statu quo + formation	Scénario B — Privatisation partielle	Scénario C — Catégorie B
Coût formation initiale An 1 (sourcé)	1 226 500 €	—	1 226 500 € (Module MHS, investissement unique)
Coût récurrent formation (turnover 18 %/an)	+220 770 €/an	—	+44 154 €/an (coût marginal sur référentiel établi)
Surcoût indiciaire catégorie B	—	—	462 000 €/an (385 €/mois × 12 × 100)
Turnover + intérim + sinistralité (inchangé)	2 969 000 €/an cumulé	Inclus dans 1,8 M€/an	Réduit (turnover -50 %)
TOTAL estimé 5 ans (100 agents)	~7 070 000 €	~8 981 000 €	~2 056 000 €

Le recalcul à partir de devis réels confirme, à moins de 1 % près, les ordres de grandeur de la version précédente : le passage en catégorie B (scénario C) reste environ 3,4× moins coûteux que le statu quo et 4,4× moins coûteux que la privatisation partielle sur 5 ans, pour un effectif de 100 agents.

V. Conclusion — recommandation actualisée à la DGOS et au Ministère

- Les devis réels collectés auprès de 10 organismes de formation et CESU (Transfaire, CNFCE, CESU33, Panacéa, SimUSanté, SIFAM, GRIEPS, ANFH, CH de Versailles, CH d'Avignon) confirment la faisabilité et le chiffrage du Module MHS, désormais documentés poste par poste et opposables devant un contrôleur de gestion.
- L'élargissement du référentiel missions à 36 missions recensées (78 % hors périmètre DEA) renforce le risque médico-légal non couvert par les scénarios A et B.
- Le passage en catégorie B demeure, à devis réels constants, le seul scénario coût-efficace sur un horizon de 5 ans, avec un écart de 5,0 M€ par rapport au statu quo et de 6,9 M€ par rapport à la privatisation partielle (base 100 agents).
- Deux briques de formation (M2 pénitentiaire, M3 bariatrie) restent à chiffrer précisément par devis avant contractualisation du Module MHS ; une brique (soins palliatifs) est prise en charge sur fonds mutualisés ANFH et ne pèse pas sur le budget de l'établissement.

Références utilisées dans cette mise à jour : TranSFaire, fiche SAU026 (juin 2026) · CESU33/CHU de Bordeaux, formation référent SSE (novembre 2025) · CNFCE, fiche SNT.104 (décembre 2025) · Panacéa Conseil & Formation Santé, fiche BLO018 (mars 2026) · CH de Versailles, formation transport PSL/IH (juin 2023, en vigueur 2026) · CH d'Avignon, programme ADE/AFGSU2 (mars 2024) · SIFAM Formations, manutention bariatrique méthode Dotte (juillet 2023) · Isis Santé, formation perfusion · ANFH, Prise en charge palliative (Stratégie décennale soins palliatifs 2024-2034) · GRIEPS, Soins somatiques en psychiatrie, réf. ECSPS01O (avril 2026) · SimUSanté/CHU Amiens-Picardie, transport néonatal et pédiatrique (mai 2026) · Document intersyndicale « Missions des ambulanciers — référentiel DEA vs pratique réelle » (27 juin 2026) · Analyse critique et budgétaire initiale (29 juin 2026).

Fait à Toulouse, le 30 juin 2026

Signataires : Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES — CHU de Toulouse, Service Transport Patients, Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9.